CHUYÊN LUẬN DƯỢC LÂM SÀNG: CEFTIZOXIM

Ceftizoxime natri • Mã ATC: J01DD07 • Cephalosporin thế hệ 3 đường tiêm

1. THÔNG TIN CHUNG & DẠNG BÀO CHẾ

• Tên hoạt chất: Ceftizoxim (dưới dạng muối Ceftizoxime natri - Ceftizoxime sodium).

• Biệt dược phổ biến: Cefizox, Ceftizox, Epocelin, Cefozim, Zoxicef.

• Dạng bào chế: Lọ bột đông khô pha tiêm/truyền tĩnh mạch: 500 mg, 1 g, 2 g (kèm dung dịch pha tiêm).

2. PHỔ KHÁNG KHUẨN & ƯU THẾ LÂM SÀNG ĐẶC THÙ

• Trực khuẩn Gram âm đường ruột: Tác dụng rất mạnh trên họ Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Providencia spp.). Bền vững trước phần lớn men beta-lactamase thông thường (trừ ESBL và Carbapenemase).

• Cầu khuẩn Gram dương: Nhạy cảm tốt với Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; hoạt tính trung bình trên tụ cầu MSSA (không có hoạt tính trên MRSA).

• ĐẶC ĐIỂM ĐẶC THÙ (VI KHUẨN KỴ KHÍ): Khác biệt với hầu hết Cephalosporin thế hệ 3 khác (như Cefotaxim, Ceftriaxon), Ceftizoxim có hoạt tính bao phủ tốt trên nhiều chủng vi khuẩn kỵ khí, bao gồm Bacteroides fragilis và Peptostreptococcus spp., rất có giá trị trong nhiễm khuẩn ổ bụng và vùng chậu.

• Phổ khuyết: Không tác dụng trên Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis/faecium, Listeria monocytogenes.

3. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ CHÍNH

1. Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới: Viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP) nặng, viêm phổi bệnh viện (HAP không do P. aeruginosa), đợt cấp viêm phế quản mạn/COPD, áp xe phổi.

2. Nhiễm khuẩn trong ổ bụng & tiểu khung: Viêm phúc mạc, áp xe trong ổ bụng, viêm phần phụ, viêm nội mạc tử cung (do bao phủ phối hợp cả Gram âm đường ruột và vi khuẩn kỵ khí).

3. Nhiễm khuẩn tiết niệu: Viêm đài bể thận cấp tính, nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng.

4. Nhiễm khuẩn huyết & Viêm màng não mủ: Nồng độ thuốc xâm nhập tốt qua màng não bị viêm.

5. Nhiễm khuẩn da - mô mềm, cơ xương khớp nặng và Bệnh lậu không biến chứng (liều duy nhất 1g IM).

4. LIỀU LƯỢNG & ĐƯỜNG DÙNG

• Người lớn (Nhiễm khuẩn thông thường): 1 g đến 2 g mỗi 8 đến 12 giờ (IV hoặc IM). Tối đa 4 g mỗi 8 giờ trong nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng.

• Trẻ em (> 6 tháng tuổi): 50 mg/kg mỗi 6 đến 8 giờ (tổng liều 150 - 200 mg/kg/ngày). Tối đa không quá 12 g/ngày.

5. HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH LIỀU THEO THANH THẢI THẬN (CrCl)

Mức thanh thải (CrCl)	Liều dùng khuyến cáo	Ghi chú lâm sàng
CrCl > 50 mL/phút	1 g - 2 g mỗi 8 - 12 giờ	Liều chuẩn không cần chỉnh
CrCl 30 - 50 mL/phút	500 mg - 1 g mỗi 12 giờ	Kéo dài khoảng cách đưa liều
CrCl 10 - 29 mL/phút	500 mg - 1 g mỗi 24 giờ	Giảm liều và đưa 1 lần/ngày
CrCl < 10 mL/phút	500 mg mỗi 24 - 48 giờ (hoặc 1g mỗi 48h)	Theo dõi sát chức năng thận & thần kinh
Lọc máu ngắt quãng (HD)	500 mg - 1 g sau mỗi buổi lọc	Bổ sung ngay sau khi kết thúc lọc máu
Lọc màng bụng (CAPD)	500 mg mỗi 24 - 48 giờ	Hiệu chỉnh tương đương CrCl < 10

6. PHA TRUYỀN & ĐIỂM NHẤN DƯỢC LÝ LÂM SÀNG (CLINICAL PEARLS)

• Kỹ thuật tiêm truyền: Tiêm tĩnh mạch chậm trong 3 - 5 phút (pha lọ 1g với 10mL nước cất). Hoặc truyền ngắt quãng trong 30 - 60 phút (pha trong 50 - 100mL NaCl 0.9% hoặc Dextrose 5%).

• Tối ưu PK/PD (%fT > MIC): Kháng sinh phụ thuộc thời gian diệt khuẩn. Ở bệnh nhân nặng tại ICU hoặc vi khuẩn có MIC cận biên, kéo dài thời gian truyền (2 - 3 giờ) giúp tối ưu hóa hiệu quả lâm sàng.

• KHÔNG CÓ CHUỖI BÊN NMTT: Ceftizoxim không chứa chuỗi N-methylthiotetrazole (NMTT) nên KHÔNG gây phản ứng kiểu Disulfiram khi

uống rượu và KHÔNG làm hạ prothrombin huyết gây rối loạn đông máu.

• CẢNH BÁO ĐỘC TÍNH THẦN KINH: Đào thải > 80% qua thận. Ở bệnh nhân suy thận nặng nếu không giảm liều, tích lũy nồng độ cao trong dịch não tủy có thể gây kích thích thần kinh, co giật, giật cơ và bệnh não chuyển hóa.